CIRUGÍA BASADA EN EVIDENCIAS

DR. MOISES CUKIER

EL TRIÁNGULO DE DECISIONES CLÍNICAS

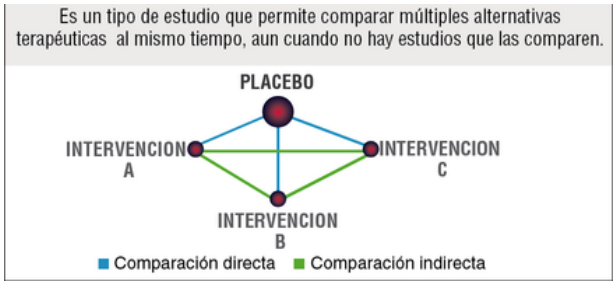
- La evidencia NO reemplaza la práctica clínica; se integra con: habilidades técnicas, experiencia/juicio clínico, y evidencia científica.
- Realidad en cirugía: menos del 10% de las conductas quirúrgicas tiene evidencia de alta calidad; menos del 40% de las intervenciones ha sido evaluada con ensayos aleatorizados.

EVOLUCIÓN HISTÓRICA: SACKETT Y COCHRANE

- Pierre Louis (siglo XIX): método numérico, bases para comparar grupos.
- David Sackett (Canadá) y Archie Cochrane (Inglaterra, 1970s): desarrollaron el marco colaborativo moderno de síntesis de evidencia.
- El logo de la Colaboración Cochrane es un forest plot de un estudio sobre corticoides prenatales (<34 semanas): estudios pequeños sin significancia individual, pero combinados mostraron reducción clara de mortalidad.

METAANÁLISIS

- Combina cuantitativamente datos de múltiples estudios para aumentar el tamaño muestral y el poder estadístico.
- Índice de heterogeneidad (I^2): debe ser menor al 25% para asegurar consistencia metodológica.
- Riesgo "garbage in, garbage out": si los estudios primarios son de baja calidad, el metaanálisis no es válido; sesgo de publicación favorece resultados positivos.



REVISIONES SISTEMÁTICAS

- Evaluación cualitativa y cuantitativa más amplia que el metaanálisis.
- Permiten analizar intervenciones clínicas, aspectos socioecológicos, costo-efectividad y efectos adversos.



FIGURA 1. Jerarquía de la evidencia.

RESOLUCIÓN CON EVIDENCIA: COCHRANE 2011

- Revisión sistemática de 8 ensayos aleatorizados (opioides vs. placebo en dolor abdominal agudo no traumático): la analgesia precoz calma el dolor sin alterar la precisión del examen físico, el error diagnóstico ni las complicaciones quirúrgicas.
- Esto desestimó la sanción y evidenció la necesidad de eliminar dogmas tradicionales sin sustento científico.

